МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

[наименование образовательной организации]
[факультет / институт]
Кафедра [название кафедры]

РЕФЕРАТ

по дисциплине «Социальная работа за рубежом»

на тему «Социальная работа в США:
становление, организация и современная практика»

Выполнил: студент(ка) ____ группы
[фамилия, имя, отчество]

Проверил: [должность]
[фамилия, имя, отчество]

Ростов-на-Дону — 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 4
1.1 Становление социальной работы как профессии 4
1.2 Организация системы социальных услуг 5
1.3 Образование, аккредитация и лицензирование 6
2 ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРАКТИКИ 7
2.1 Ведущие теоретические подходы 7
2.2 Технология работы с клиентом и сообществом 8
2.3 Этические принципы и принятие решений 9
3 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 10
3.1 Работа с детьми, семьями и в школе 10
3.2 Медицинская, клиническая и кризисная работа 11
3.3 Жилищная помощь, занятость и цифровизация 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 14
ПРИЛОЖЕНИЕ А 15

ВВЕДЕНИЕ

Социальная работа в США представляет собой профессиональную систему, объединяющую помощь конкретному человеку, развитие сообществ и участие в формировании социальной политики. Ее отличительной чертой является подход «человек в среде»: трудности рассматриваются через взаимодействие личных ресурсов, семейных отношений, экономических условий и доступности институтов. Поэтому практика не сводится ни к выдаче пособий, ни исключительно к психологическому консультированию.

Актуальность темы связана с усложнением социальных проблем. Бездомность, неблагополучие семей, психические расстройства, зависимости, старение населения и миграция требуют согласованной работы медицинских, образовательных, жилищных и правовых служб. Распространение дистанционных технологий расширяет доступ к помощи, но одновременно создает риски цифрового неравенства и нарушения конфиденциальности. В этих условиях возрастает значение профессиональных стандартов, супервизии и этической регуляции.

Целью работы является анализ становления, организации, методов и современных направлений социальной работы в США. Объектом исследования выступает социальная работа как профессиональная система, предметом — ее институциональные формы, образовательные стандарты, методы и этические принципы.

Для достижения цели поставлены задачи: рассмотреть этапы профессионализации; охарактеризовать распределение функций между государственными и негосударственными участниками; проанализировать подготовку и лицензирование специалистов; раскрыть ведущие теоретические подходы и этапы помощи; определить роль Кодекса этики NASW; исследовать основные сферы и современные вызовы практики.

В работе применяются историко-генетический, системный и структурно-функциональный подходы, анализ учебной и научной литературы, профессиональных документов и официальной статистики. Использованы работы Дж. Аддамс, М. Ричмонд, М. Пейна, Ф. Римера и других авторов, а также документы CSWE, NASW и Бюро трудовой статистики США. Американский опыт рассматривается критически, с учетом его зависимости от законодательства, финансирования и децентрализации.

1 ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

1.1 Становление социальной работы как профессии

Истоки американской социальной работы связаны с общинной взаимопомощью и благотворительностью. Во второй половине XIX века индустриализация, урбанизация и иммиграция увеличили масштаб бедности. Разрозненная помощь оказалась недостаточной, что стимулировало обследование семей, координацию агентств и профессиональную подготовку [8; 10].

Созданное в 1877 году в Буффало Charity Organization Society стремилось упорядочить благотворительность, регистрировать обращения и изучать причины нужды. Этот опыт способствовал развитию индивидуальной кейсовой работы, но нередко сопровождался моральной оценкой бедных. Движение поселений предложило иной акцент. В Халл-хаусе, открытом Джейн Аддамс и Эллен Гейтс Старр в Чикаго в 1889 году, образование, поддержка иммигрантов и общественные исследования соединялись с реформами трудового законодательства и развитием сообщества [1].

Две модели сформировали напряжение между адаптацией человека и изменением среды. М. Райш показывает, что в истории профессии постоянно взаимодействовали социальная справедливость, поиск статуса, зависимость от финансирования и функции социального контроля [8].

В 1898 году началась систематическая подготовка благотворительных работников в Нью-Йорке. Книга Мэри Ричмонд «Социальный диагноз» 1917 года закрепила последовательное исследование случая на основе социальных свидетельств и факторов среды [9]. Закон о социальном обеспечении 1935 года расширил федеральную ответственность и сферу занятости специалистов. Создание CSWE в 1952 году и NASW в 1955 году укрепило единые образовательные и этические стандарты.

Профессия развивалась через взаимодействие благотворительности, образования, государственной политики и общественных движений. Ее результатом стало соединение поддержки человека с устранением институциональных барьеров.

1.2 Организация системы социальных услуг

Система социальных услуг США децентрализована и включает федеральные агентства, штаты, местные администрации, некоммерческие организации, частные поставщики, школы и медицинские сети. Единого ведомства, управляющего всей социальной работой, нет. Социальное обеспечение и профессиональная помощь взаимосвязаны, но не тождественны.

Финансирование объединяет налоги, федеральные гранты, средства штатов, Medicaid, страхование и филантропию. Многообразие источников поддерживает разные формы помощи, но порождает разрывы между программами. Доступность зависит также от времени ожидания, транспорта, стоимости, языка и доверия к учреждению.

Кейс-менеджмент объединяет оценку потребностей, связь с ресурсами, согласование поставщиков и контроль результата. При выписке из стационара может одновременно требоваться уход, транспорт, лекарства и безопасное жилье. Социальный работник не заменяет других специалистов, а обеспечивает связность помощи [10].

Таблица 1 — Распределение функций в системе социальных услуг

Участник	Основные функции
Федеральный уровень	Законодательство, национальные программы, гранты и статистика
Штат	Лицензирование, администрирование программ и надзор
Местный уровень	Прием обращений, координация помощи и контракты
Некоммерческий и частный секторы	Непосредственные услуги, адвокация и инновационные проекты

Децентрализация поддерживает местную гибкость, но создает территориальное неравенство. Качество обеспечивается лицензированием, аккредитацией и супервизией. Число встреч не должно подменять оценку реального благополучия и соблюдения прав клиента.

1.3 Образование, аккредитация и лицензирование

Профессиональная подготовка ведется преимущественно по программам бакалавриата BSW и магистратуры MSW. Первая ориентирует на генералистскую практику с индивидами, семьями, группами, организациями и сообществами. Вторая углубляет подготовку в клинической, административной, исследовательской или политической специализации. Докторские программы направлены преимущественно на исследования, преподавание и профессиональное лидерство.

Аккредитация программ осуществляется Советом по образованию в области социальной работы. Стандарты CSWE 2022 года построены вокруг девяти компетенций: этичного поведения; защиты прав и справедливости; учета разнообразия и инклюзии; взаимосвязи исследований и практики; участия в социальной политике; установления контакта; оценки; вмешательства; оценивания результатов [3]. Компетентность означает способность интегрировать знания, ценности и навыки, а не только завершить теоретический курс.

Центральным элементом является полевая практика. Под руководством квалифицированного специалиста студент применяет теорию, ведет документацию и получает обратную связь. Такой формат связывает университет с реальной ответственностью и позволяет оценивать наблюдаемые профессиональные действия.

Лицензирование регулируется штатами, поэтому единой федеральной лицензии не существует. Юрисдикции различаются названиями разрешений, требованиями к экзамену, стажу, супервизии и непрерывному образованию. В обобщенной модели выделяются бакалаврский, магистерский, продвинутый генералистский и клинический уровни. Самостоятельная психотерапевтическая практика обычно требует степени MSW, постдипломной управляемой практики и клинической лицензии. Наличие диплома само по себе не подтверждает такое право.

Супервизия выполняет образовательную, поддерживающую и контрольную функции, помогает анализировать случай и предотвращать выгорание. Сильными сторонами модели являются проверяемость компетенций и связь с практикой, ограничениями — стоимость обучения и различия требований штатов.

2 ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ЭТИКА ПРАКТИКИ

2.1 Ведущие теоретические подходы

Теоретическая основа социальной работы интегрирует знания о личности, семье, группе, организации, культуре и политике. Подход «человек в среде» исключает объяснение трудностей только индивидуальными особенностями. Невыполнение медицинских рекомендаций, например, может быть связано не с мотивацией, а с отсутствием транспорта, дохода или безопасного жилья. Вмешательство поэтому направляется одновременно на человека и условия его жизни [6; 10].

Системный и экологический подходы анализируют взаимозависимость элементов, обратные связи и соответствие потребностей ресурсам. Ресурсная перспектива выявляет способности, успешный опыт и отношения поддержки, не игнорируя при этом риск и страдание. Эмпауэрмент развивает эту логику через расширение выбора, участия и контроля человека или сообщества над решениями. Помощь не должна создавать зависимость от эксперта.

Травма-информированная практика учитывает последствия насилия, утраты и хронической небезопасности. Ее ориентирами становятся безопасность, предсказуемость, выбор и сотрудничество. Она применима не только в терапии, но и к организации приема, документам и проверкам. Антиопрессивный подход обращает внимание на структурное неравенство и профессиональную власть. Культурная компетентность предполагает рефлексию и уточнение опыта клиента, а не приписывание ему стереотипных характеристик группы.

Когнитивно-поведенческие, кризисные, задачно-центрированные, психодинамические и иные модели выбираются в соответствии с проблемой, доказательствами, предпочтениями клиента и квалификацией работника. М. Пейн рассматривает теории как средства объяснения и критической оценки практики, а не как универсальные рецепты [6].

Доказательная практика объединяет исследования, профессиональный опыт, особенности ситуации и предпочтения человека. Недостаток исследований требует открытого признания неопределенности, консультации и усиленного мониторинга. Таким образом, теория ориентирует решение, но его качество проверяется через этику и фактический результат.

2.2 Технология работы с клиентом и сообществом

Технология социальной работы представляет собой циклический процесс. В модели Д. Хепворта и соавторов выделяются включение, исследование и оценка, планирование, измененческая работа и завершение [4]. Новые сведения или изменение риска могут потребовать возврата к предыдущему этапу. Документация фиксирует основания решений, действия участников и результаты.

При установлении контакта разъясняются цель встречи, роли и пределы конфиденциальности. Оценка объединяет сведения о проблеме, ресурсах, культуре, отношениях и безопасности. Планирование переводит намерения в конкретные цели и распределяет ответственность с учетом факторов, которые клиент не контролирует. Завершение включает закрепление изменений, план поддержки и понятный порядок повторного обращения.

Таблица 2 — Основные этапы социальной работы

Этап	Содержание
Контакт	Разъяснение роли, согласия и границ помощи
Оценка	Проверка сведений о рисках, ресурсах и среде
Планирование	Совместное определение целей, действий и сроков
Вмешательство	Консультирование, ресурсная связь, группа и адвокация
Оценивание	Сопоставление результатов и опыта клиента
Завершение	План устойчивой поддержки или передача случая

Работа с сообществом начинается с совместного определения проблемы и картирования ресурсов. Жители включаются не только в обсуждение готового проекта, но и в постановку приоритетов и оценку. Профессиональные записи должны отделять факты от суждений, содержать только необходимые сведения и быть защищенными от несанкционированного доступа. Оценка результата учитывает как измеримые изменения, так и опыт клиента и непредусмотренные последствия.

2.3 Этические принципы и принятие решений

Кодекс этики NASW закрепляет шесть ценностей: служение, социальную справедливость, достоинство и ценность человека, значимость отношений, честность и компетентность [5]. Он определяет ответственность перед клиентами, коллегами, профессией и обществом. Однако документ не дает автоматического ответа для каждого случая: специалисту приходится разрешать столкновение обязанностей.

Самоопределение означает участие клиента в выборе целей и методов. Оно может ограничиваться законом и серьезным предсказуемым риском, но такое ограничение требует объяснения и применения наименее ограничительной допустимой меры. Информированное согласие включает понятное описание услуги, рисков, альтернатив, стоимости и использования записей. Подпись не заменяет реального понимания, поэтому применяются перевод и доступные форматы коммуникации.

Конфиденциальность укрепляет доверие, но не является абсолютной. Исключения связаны с законом, защитой от серьезного вреда и согласованным обменом сведениями. Пределы разъясняются заранее, а раскрывается только необходимый объем информации. Цифровые сервисы требуют защищенной связи, проверки местоположения клиента и отдельного внимания к границам онлайн-общения [7].

Дуальные отношения оцениваются с точки зрения эксплуатации, конфликта интересов и утраты объективности. Особенно недопустимы сексуальные отношения с клиентами и финансовое использование доверия. В малых сообществах неизбежные пересечения ролей сопровождаются прозрачными договоренностями и супервизией.

Этическое решение включает проверку фактов, определение участников, анализ Кодекса и закона, сравнение альтернатив, консультацию и оценку последствий. Забота о себе также входит в профессиональную ответственность, поскольку перегрузка ухудшает суждение. При этом организация обязана поддерживать безопасную нагрузку, обучение и отдых, а не переносить всю ответственность за выгорание на работника [5; 7].

3 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

3.1 Работа с детьми, семьями и в школе

Работа с детьми и семьями включает профилактику неблагополучия, поддержку родительства, кризисное вмешательство, защиту от жестокого обращения, приемное воспитание и воссоединение семьи. Федеральное законодательство задает общие ориентиры, но процедуры и организационные структуры различаются по штатам. Службы защиты детей реагируют на сообщения о риске, проводят расследование или альтернативную оценку и определяют необходимые услуги.

Безопасность ребенка неотделима от условий семьи. Бедность сама по себе не равна жестокому обращению, однако жилищная нестабильность, недоступность медицины и нагрузка на опекунов повышают риск. Поэтому защита сочетается с материальной поддержкой, лечением, развитием родительских навыков и укреплением родственной сети. При безопасных условиях приоритетом становится сохранение устойчивых семейных связей. Разлучение требует правовых оснований и проверки менее ограничительных альтернатив.

Семейно-ориентированная оценка учитывает не только риск, но и ресурсы всех участников. Дети включаются в обсуждение с учетом возраста и развития, а культурные связи признаются самостоятельной ценностью. Профилактические услуги наиболее доступны тогда, когда обращение за поддержкой не воспринимается семьей как автоматическая угроза расследования. Разграничение помощи и контроля, ясная информация о правах и раннее обращение формируют доверие.

Школьные социальные работники связывают учащегося, семью, педагогов и внешние службы. Они работают с пропусками занятий, кризисами, издевательствами, жилищной нестабильностью и включением детей с особыми потребностями. Их деятельность не ограничивается консультированием: групповые программы, консультирование персонала и анализ дисциплинарных правил позволяют устранять системные препятствия обучению.

Устойчивая помощь сочетает защиту, профилактику и ресурсы, требуя партнерства школы, здравоохранения, жилищных и юридических служб.

3.2 Медицинская, клиническая и кризисная работа

В больницах, амбулаторных центрах, хосписах и реабилитационных учреждениях социальные работники оценивают психосоциальные факторы, поддерживают пациента и семью, содействуют выписке и связывают лечение с ресурсами сообщества. Диагноз рассматривается в контексте жилья, дохода, ухода и культуры. Это снижает вероятность того, что медицински правильный план окажется невыполнимым из-за социальных обстоятельств.

В паллиативной помощи значимы обсуждение ценностей, семейная коммуникация, скорбь и практическая организация ухода. В реабилитации специалист поддерживает адаптацию к изменившимся возможностям, доступность среды и участие в общественной жизни. Социальная работа помогает медицинской команде видеть не только заболевание, но и субъективный опыт человека.

Клинические социальные работники проводят психосоциальную оценку, психотерапию, кризисное вмешательство и координацию помощи при психических расстройствах и зависимостях. Независимая деятельность требует соответствующей лицензии и соблюдения границ компетенции. Даже при применении психотерапевтического метода сохраняется внимание к дискриминации, насилию и экономической небезопасности.

Кризисная система объединяет телефонную поддержку, мобильные бригады, кратковременную стабилизацию, неотложную помощь и последующее сопровождение. Общенациональная линия 988, запущенная в 2022 году, расширила доступ к первичной поддержке, однако не заменяет местную сеть услуг. При кризисе приоритетом становятся безопасность, деэскалация и совместный план ближайших действий. Госпитализация и принуждение применяются только на правовых основаниях, а не как универсальный ответ.

В работе с зависимостями соединяются лечение, мотивационное консультирование, снижение вреда, восстановление и семейная поддержка. Неосуждающая коммуникация уменьшает стигматизацию и способствует обращению за помощью. Результат оценивается через безопасность, здоровье, качество жизни и устойчивость поддержки.

3.3 Жилищная помощь, занятость и цифровизация

Социальная работа с бездомностью включает профилактику выселения, экстренное размещение, быстрое повторное расселение и постоянное поддерживаемое жилье. Подход Housing First исходит из приоритета жилищной стабильности без требования предварительно решить все проблемы человека. Сопровождение сохраняет значение после получения жилья. Устойчивый результат зависит не только от кейс-менеджмента, но и от наличия доступного жилого фонда.

По данным Бюро трудовой статистики США, в 2024 году насчитывалось 810900 рабочих мест социальных работников, а медианная годовая оплата составляла 61330 долларов. Прогноз на 2024–2034 годы предполагает рост занятости на 6 процентов [2]. Эти общенациональные показатели не учитывают различия регионов, стоимости жизни и квалификации.

Таблица 3 — Отдельные показатели профессии по данным BLS

Показатель	Значение
Рабочие места в 2024 году	810900
Медианная оплата в мае 2024 года	61330 долларов
Прогноз роста на 2024–2034 годы	6 процентов

Цифровизация проявляется в видеоконсультировании, электронных записях и дистанционной супервизии. Она сокращает транспортные барьеры, но требует защищенной связи, конфиденциального пространства и плана действий при кризисе. Отсутствие интернета или навыков способно закрепить неравенство. Автоматизированные оценки риска не должны заменять профессиональное суждение, поскольку алгоритмы могут воспроизводить историческую дискриминацию.

Перспективы профессии связаны с интеграцией медицинской, жилищной и социальной помощи, развитием профилактики и участием клиентов в проектировании услуг. Необходим баланс между технологией и отношениями, подотчетностью и профессиональным суждением, клинической специализацией и устранением структурных причин неблагополучия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальная работа в США сформировалась на пересечении благотворительности, общественных реформ, университетского образования и государственной политики. Общества организации благотворительности способствовали систематизации индивидуального обследования, а движение поселений укрепило ориентацию на сообщество и социальную справедливость. Наследие Мэри Ричмонд и Джейн Аддамс отражает взаимодополняющие измерения профессии: работу с конкретным случаем и преобразование среды.

Децентрализация поддерживает локальную гибкость, но создает неравенство доступа. Кейс-менеджмент и партнерство компенсируют фрагментацию, однако не устраняют дефицит жилья, кадров и финансирования. Качество оценивается реальной возможностью своевременно получить помощь.

Образование BSW и MSW, полевая практика, стандарты CSWE и лицензирование формируют основу профессионализма. Подход «человек в среде» и ресурсная перспектива соединяют личные и социальные факторы. Технология помощи включает контакт, оценку, планирование, вмешательство, оценивание и завершение с участием клиента.

Кодекс NASW закрепляет служение, справедливость, достоинство, значимость отношений, честность и компетентность. Самоопределение, согласие и конфиденциальность согласуются с безопасностью и законом через обоснованное этическое решение. Анализ сфер практики подтверждает взаимосвязь проблем: защита детей связана с ресурсами семьи, восстановление здоровья — с условиями жизни, а преодоление бездомности — с доступностью жилья.

Цель достигнута: рассмотрены история, организация, подготовка, теория, технология, этика и сферы социальной работы США. Американский опыт показывает значение компетенций, супервизии, лицензирования и координации. Его критическое использование предполагает не перенос отдельных институтов, а адаптацию целостной помощи, соединяющей личные изменения, доступную среду и социальную справедливость.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Addams J. Twenty Years at Hull-House. New York: Macmillan, 1910

2. Bureau of Labor Statistics. Social Workers // Occupational Outlook Handbook. U.S. Department of Labor, 2025. URL: https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/social-workers.htm (дата обращения: 06.11.2026)

3. Council on Social Work Education. Educational Policy and Accreditation Standards for Baccalaureate and Master's Social Work Programs. Alexandria, VA: CSWE, 2022

4. Hepworth D. H., Vang P. D., Blakey J. M., Schwalbe C., Evans C. B. R., Rooney R. H., Rooney G. D., Strom K. Direct Social Work Practice: Theory and Skills. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2017

5. National Association of Social Workers. Code of Ethics of the National Association of Social Workers. Washington, DC: NASW, 2021. URL: https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English (дата обращения: 06.11.2026)

6. Payne M. Modern Social Work Theory. 5th ed. London: Red Globe Press, 2020

7. Reamer F. G. Social Work Values and Ethics. 5th ed. New York: Columbia University Press, 2018

8. Reisch M. Lessons from Social Work's History for a Tumultuous Era // Social Service Review. 2019. Vol. 93, No. 4. P. 581–607. DOI: 10.1086/706741

9. Richmond M. E. Social Diagnosis. New York: Russell Sage Foundation, 1917

10. Zastrow C., Hessenauer S. L. Empowerment Series: Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People. 13th ed. Boston: Cengage, 2023

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Краткий глоссарий американской социальной работы

Таблица 4 — Основные термины и их содержание

Термин	Содержание
Person-in-environment	Одновременный анализ личности и социальной среды
Generalist practice	Работа с разными системами на основе общих компетенций
Case management	Оценка, планирование, связь ресурсов и мониторинг
Advocacy	Представление интересов и изменение несправедливых правил
Empowerment	Расширение выбора, участия и контроля над решениями
Supervision	Профессиональное руководство, обучение и поддержка
Evidence-based practice	Интеграция исследований, опыта и предпочтений клиента
Housing First	Приоритет постоянного жилья в сочетании с поддержкой

Приведенные определения раскрывают общий профессиональный смысл терминов. Конкретные полномочия специалиста и содержание услуг проверяются по действующим правилам соответствующего штата и организации.